

Результаты цитологического скрининга рака шейки матки 2006-2010 гг. по Семейскому региону

Бань Т.П., Шалаганова К.Б., Кыдырбаева Ж.Н., Суртаева Ж.Д., Карипова М.К.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Проведен анализ результатов цитологического скрининга рака шейки матки 2006-2010 гг. по Семейскому региону. Работа показала рост выявляемости рака по скринингу в 15 раз 0,01%-2007 г., 0,07%-2008 г., 0,15%-2009 г., 0,1%-2010 г. Этому способствовало проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров и позволило получить более качественный материал. Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау. Метод Папаниколау имеет больше преимуществ при проведении скрининга.

В мире накоплен большой опыт по проведению цитологического скрининга рака шейки матки (РШМ). Проведение организованного скрининга РШМ способствовало снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%.

Цель исследования

- провести анализ эффективности диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга 2006-2010гг.

Материал и методы исследования

В Казахстане цитологический скрининг рака шейки матки проводится с 2005 года.

2005 год: 20 – 34 года

2006 и 2007 гг.: 18 – 49 лет.

С 2008 года: 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет.

Обследовано в 2006 г. - 145249 женщин, 2007 г. - 138684 женщин, 2008 г. - 22630 женщин, 2009 г. – 18311 женщин, 2010 г. – 17852 женщин. Материал для исследования получали из шейки матки при помощи Cervix-Brush. Метод окраски препаратов - по Романовскому в 2006, 2007 гг. В 2008 году - 60% всех исследований окрашены по методу Папаниколау и 40% по Романовскому. С 2009 года все скрининговые исследования 100% окрашиваются по методу Папаниколау(Пап-тест).

Обсуждение и результаты исследования

Установлено, что решающим фактором, влияющим на эффективность скрининга, является широта охвата скринингом женского населения. Для решения проблемы охвата скринингом женского населения проводили разъяснительную работу, привлечение средств массовой информации, издания популярных печатных материалов. Вторым не менее важным фактором эффективности проведения скрининга является адекватность мазка. Точность цитологического исследования определяется качеством полученного материала (клеточным составом мазка). Материал расценивался, как адекватный для исследования, если в мазке имелись клетки плоского, метаплазированного и эндоцервикального эпителия, т.е. материал должен быть получен из зоны трансформации (зона стыка плоского и цилиндрического эпителия, где наиболее часто возникает опухоль). Для получения адекватного материала мазки рекомендовались брать шеткой - браш. Самую «опасную» категорию женщин представляет именно «недостаточно адекватный материал» т.к. гинеколог не всегда посчитает нужным «перебрать» материал и при наличии невидимой визуальной патологии у такой женщины большая вероятность развития предрака (дисплазии), а затем и рака.

Семей өңірі бойынша 2006-2010 жылдарға жатыр мойны обырына цитологиялық скринингтің нәтижелеріне талдау жүргізілді. Жұмыс обырдың анықталу өсімінің скрининг бойынша 15 есе 0,01%-2007 ж., 0,07%-2008 ж., 0,15%-2009 ж., 0,1%-2010 ж. өскенін көрсетті. Бұған гинекологтар мен акушерлерге арналған оқыту семинарлары, тренингтердің өткізілуі ықпал етті және неғұрлым сапалы материал алуға септігін тигізді. Бұрынғы барлық обырлар Папаниколау әдісі бойынша анықталған болатын. Скрининг жүргізу барысында Папаниколау әдісінің артықшылығы көп.

Проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров позволило снизить количество неинформативных мазков (с 20.3% в 2007 году до 1,36% в 2010 году), а значит получить более качественный материал, следовательно, диагностировать больше ранней патологии шейки матки. Что касается злокачественных процессов, то наблюдается рост выявляемости рака по скринингу в 12,5 раз (0,01% в 2007г, 0,07% в 2008 г, 0,15% в 2009г, 0,1% в 2010г.)

	2007	2008	2009	2010
Ca in situ	2	6	4	5
микроинв	1	2	14	3
инвазивн	17	8	11	10
всего	20	16	29	18
% ранних раков	15	50	62	44

Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау, что еще раз подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Очень важным фактором эффективности цитологического скрининга является адекватное обследование и лечение выявленных больных. Женщины с выявленной патологией (цитологические заключения даются по терминологии Бетесда) ASCUS (атипия неясного значения), LSIL (легкая степень дисплазии) наблюдались у участкового гинеколога по месту жительства с последующим цитоконтролем. Женщины с более серьезной выявленной патологией - умеренная, тяжелая степень дисплазии(HSIL),подозрение на злокачественный процесс направлялись в онкодиспансер для углубленного обследования (кольпоскопия, биопсия) и лечения. За 2010год 50% впервые взятые на учет женщины по раку шейки матки были выявлены при профилактическом осмотре.

Выводы

Для эффективного проведения скрининга необходимо соблюдение трех основных факторов - широта охвата женского населения подлежащего исследованию, полноценность полученного цитологического материала, обследование и лечение выявленных больных. Метод окраски цитологических препаратов по Папаниколау показал себя как метод более эффективный при диагностике патологии шейки матки, имеет больше преимуществ при проведении скрининга.